ONEMA-POP-005 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-005 — Manejo de Crise Asmática e Insuficiência Respiratória Aguda

1. Identificação institucional

983558

2. Objetivo e abrangência

Reconhecer gravidade respiratória, iniciar medidas de suporte dentro da competência e assegurar encaminhamento sem

atraso. Atendimento domiciliar presencial ou orientação digital conforme indicação; não substitui assistência de

emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado: triagem, avaliação, monitorização, medidas de suporte e administração apenas com

prescrição/protocolo institucional válido e recursos apropriados. Não iniciar manejo domiciliar de quadro grave em

substituição à emergência. Indicações: Dispneia aguda, sibilância, piora de asma conhecida, dificuldade respiratória em

atendimento ou teleorientação. Limites/contraindicações: Não considerar asma como diagnóstico confirmado sem excluir

anafilaxia, pneumotórax, tromboembolismo, edema pulmonar, corpo estranho e outras causas. Não manter em domicílio

com sinais de gravidade.

4. Materiais e responsabilidade de fornecimento

Enfermeiro (presencial): oxímetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, EPI e telefone funcional; oxigênio,

aerocâmara e dispositivos de suporte somente se previstos, disponíveis e com equipe capacitada. Paciente/responsável:

inalador prescrito e plano de ação, quando existentes; medicamentos não presumidos disponíveis.

5. Avaliação e preparação

Avaliar capacidade de falar, postura, nível de consciência, esforço respiratório, frequência respiratória, pulso, saturação e

ausculta (presencial); história de internação/UTI, uso de resgate e resposta, alergias e gatilhos. Na teleorientação, não

confiar em oximetria isolada ou ausência de sibilos.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar localização exata do paciente, acompanhante presente e canal de retorno; em atendimento digital manter

contato durante a triagem.

2. Verificar imediatamente se há incapacidade de falar frases, cianose, confusão/sonolência, exaustão, tórax silencioso,

piora rápida ou sinais de anafilaxia; se presentes, orientar/acionar SAMU 192 sem aguardar outras medidas.

3. Se presencial e seguro, posicionar sentado/confortável, reduzir esforço e realizar avaliação ABCDE com oximetria e

sinais vitais, sem retardar remoção.

4. Perguntar qual plano escrito e medicação de alívio foram prescritos; orientar uso conforme plano individual vigente,

checando dispositivo, validade e técnica; não criar dose ou esquema de prescrição pela ONEMA.

5. Quando houver prescrição ou protocolo formal e recursos disponíveis, executar terapêutica permitida e monitorar

resposta; em agravamento ou ausência de melhora, acionar emergência imediatamente.

6. Reavaliar fala, trabalho respiratório, consciência, frequência respiratória e SpO2; registrar horários e resposta; não

utilizar melhora transitória como critério único de alta.

7. Comunicar ao serviço de destino informações objetivas, medicações já utilizadas e horários; orientar acompanhante a

manter vigilância até a chegada do socorro.

8. Após estabilização por serviço habilitado, programar revisão do plano de ação, técnica inalatória e seguimento médico;

não substituir a avaliação de urgência.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

SAMU 192 diante de alteração de consciência, cianose, dificuldade para falar, esforço extremo, tórax silencioso, instabilidade ou piora. Em qualquer dúvida diagnóstica relevante, encaminhamento presencial urgente.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar sinais de retorno, uso exclusivo do plano prescrito, evitar gatilhos identificados, técnica inalatória e acompanhamento após exacerbação.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação e consentimento; modalidade; horário de início e evolução; queixas, antecedentes e sinais objetivos; avaliação e decisão clínica; ações e responsáveis; acionamentos e horários; resposta, orientações, destino e continuidade; assinatura do enfermeiro e trilha de auditoria na Carteira Digital ONEMA.

10. Referências técnicas rastreáveis

Ministério da Saúde. PCDT Asma (atualizado 2026)
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/a/asma/view
Ministério da Saúde. Linha de Cuidado Asma — manejo inicial
https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/asma/servico-de-atendimento-movel/manejo-inicial/
GINA. 2026 Strategy Report — consultar recomendações originais e direitos de uso
https://ginasthma.org/2026-gina-strategy-report/
Pontos para revisão do RT: escopo de autonomia e protocolos locais; aplicabilidade ao atendimento remoto; compatibilidade de insumos e dispositivos; fluxo de referência/contrarreferência; verificação de versão e seção de cada fonte.